

PACIENTE N°: 30600

NOMBRE: PENAZZI PALACIOS DAVID OSVALDO

EDAD: 59 AÑOS

MÉDICO: DR. MARIO CAMARGO

FECHA: 03/04/2024

RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA

Técnica

Se realiza estudio con equipo de alto campo de 3T realizando secuencias Dixon en axial, sagitales.

Descripción:

Leve edema inflamatorio del tejido celular subcutáneo en línea media lumbar y de los musculo paraespinales subyacente.

Rectificación de la lordosis lumbar.

Signos de espondiloartrosis y discopatía degenerativa.

Leve abombamiento discal difuso y simétrico L1/2 y L2/3 que impronta el saco tecal sin compromiso radicular.

Acentuado abombamiento discal difuso L3/4 con componente foraminal bilateral a predominio izquierdo que impronta el saco tecal con compromiso radicular de L3 izquierda.

Secuestro discal de localización paracentral izquierda posterior a L4 que estenosa el receso lateral y compromete a la raíz nerviosa de L4 izquierda.

Protrusión discal posterior difusa y foraminal bilateral L4/5 que impronta el saco tecal sin compromiso radicular.

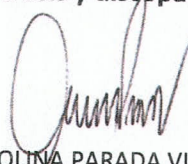
La médula espinal distal y la cola de caballo muestran morfología y señal normal.

Hipertrofia ligamentaria e hidrartrosis facetaria bilateral L4/5.

En la secuencia panorámica de columna completa se observa rectificación cervical y espondiloartrosis y discopatía degenerativa cervico-dorsal a predominio cervical.

Conclusión:

- Leve edema del TCS lumbar y de los musculo paraespinales subyacentes.
- Rectificación lumbar.
- Espondiloartrosis y discopatía degenerativa multinivel con compromiso radicular de L3 izquierda.
- Secuestro discal que produce compromiso radicular de L4 izquierda.
- Hipertrofia ligamentaria e hidrartrosis facetaria bilateral L4/5.
- En panorámica: rectificación cervical, espondiloartrosis y discopatía degenerativa cervico-dorsal.



DRA. CAROLINA PARADA VILLAVICENCIO
MÉDICO RADIOLOGO
MAT P-1784